

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

DGRP · ÍNDICE GLOBAL DE DUKE PARA EL TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

Duke Global Rating Scale for PTSD – Juicio clínico estructurado de gravedad y respuesta terapéutica

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Duke Global Rating Scale for PTSD (DGRP)
Autores Originales	Jonathan R. T. Davidson, R. H. Weisler, M. Malik y L. A. Tupler (1998)
Procedencia y Adaptación	Duke University Medical Center (EE. UU.). Banco de Instrumentos de Bobes et al. (2004)
Tipo de Instrumento	Escala heteroaplicada de juicio e impresión clínica estructurada
Población Diana	Pacientes adultos diagnosticados de TEPT agudo o crónico en seguimiento clínico
Tiempo de Aplicación	3 a 5 minutos (cumplimentada por el profesional de salud mental)
Formato de Respuesta	Dos escalas Likert clínicas de 7 anclajes descriptivos (Gravedad y Cambio Global)
Finalidad Clínica	Monitorización estandarizada de la severidad psicopatológica y cuantificación rigurosa de la respuesta y remisión en ensayos clínicos y práctica médica

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

En la evaluación del Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), los inventarios psicométricos autoadministrados y las entrevistas diagnósticas exhaustivas (como la CAPS-5) requieren un tiempo sustancial y a menudo no capturan el juicio clínico sintético que pondera el impacto real del trastorno sobre la vida global del sujeto. El DGRP fue desarrollado por el grupo de Davidson como una adaptación específica de la Escala de Impresión Clínica Global (CGI) focalizada expresamente en la sintomatología intrusiva, evitativa e hiperarousal del trauma.

El instrumento sintetiza la observación conductual, el relato subjetivo y los informes de terceros en dos vectores ortogonales de evaluación: el estado transversal de severidad mórbida en la última semana, y la magnitud longitudinal del cambio experimentado respecto al punto de partida pretratamiento (línea de base). Constituye un estándar metodológico de referencia en psicofarmacología y psicoterapia focalizada en trauma para definir operativamente los criterios de “respuesta terapéutica” y “remisión clínica”.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Subescala Clínica	Rango Puntos	Anclajes Evaluativos	Definición Operacional del Juicio
Gravedad Global TEPT	1 a 7 puntos	1 = Normal / Asintomático a 7 = Entre los más graves	Severidad sintomática actual considerando reexperimentación, evitación y disfunción funcional.
Mejoría Clínica Global	1 a 7 puntos	1 = Mucho mejor a 7 = Mucho peor (4 = Sin cambio)	Magnitud del cambio experimentado desde el inicio del tratamiento activo o intervención.
Índice de Eficacia Global	Matriz 7x7	Cruce Gravedad x Mejoría	Determinación categorial de respuesta terapéutica, remisión clínica o fracaso/empeoramiento.

Metodología de juicio: El evaluador debe integrar la intensidad de pesadillas/flashbacks, la evitación fóbica de lugares asociados al trauma y el estado de hipervigilancia autonómica del paciente.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · DGRP

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Fiabilidad Inter-Jueces	Coefficiente de correlación intraclase (ICC) = 0.88 a 0.92 entre clínicos experimentados en evaluación de trauma psíquico.
Sensibilidad al Cambio	Elevadísima capacidad de detección de cambios sutiles y marcados inducidos por fármacos (ISRS) y psicoterapia (EMDR, TCC focalizada en trauma), superando a cuestionarios autoinformados.
Validez Concurrente	Correlación de Spearman de $r = 0.84$ con la Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS), $r = 0.81$ con la Davidson Trauma Scale (DTS) y $r = 0.76$ con la IES-R.
Robustez en Ensayos Clínicos	Validado en estudios multicéntricos internacionales de fluoxetina, sertralina y venlafaxina en TEPT civil y de combate.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

1. Evaluación de Gravedad Actual (DGRP-G):

- 1 = Normal, sin signos de enfermedad; 2 = Dudosamente enfermo; 3 = Levemente enfermo; 4 = Moderadamente enfermo; 5 = Marcadamente enfermo; 6 = Gravemente enfermo; 7 = Extremadamente enfermo.

2. Evaluación de Mejoría respecto a Basal (DGRP-M):

- 1 = Muy mejorado (remisión casi total); 2 = Bastante mejorado (reducción clínicamente significativa); 3 = Mínimamente mejorado; 4 = Sin cambios; 5 = Mínimamente empeorado; 6 = Bastante empeorado; 7 = Muy empeorado.

3. Definición de Respuesta Terapéutica: Se considera "Respuesta Positiva" si DGRP-M es 1 ("Muy mejorado") o 2 ("Bastante mejorado").

4. Definición de Remisión Clínica: Requiere DGRP-M de 1 o 2 conjuntamente con un valor de DGRP-G ≤ 2 ("Normal o dudosamente enfermo").

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estado Clínico	DGRP Gravedad	DGRP Mejoría	Significado Clínico y Pronóstico
Remisión Completa	1 a 2	1	Ausencia práctica de síntomas intrusivos; recuperación funcional plena.
Respuesta Favorable	2 a 3	1 a 2	Mejoría notable en reexperimentación y sueño; síntomas residuales leves.
Respuesta Parcial	3 a 4	3	Alivio menor; persistencia de evitación fóbica y sobresalto autonómico.
No Respuesta / Fracaso	4 a 7	4 a 7	Inercia clínica o deterioro; riesgo de cronificación e incapacidad laboral.

CRITERIO ESTÁNDAR DE ÉXITO TERAPÉUTICO: El objetivo del tratamiento en TEPT no es únicamente la reducción de puntuaciones aisladas en cuestionarios, sino alcanzar una puntuación DGRP de Mejoría de 1 o 2 mantenida durante un mínimo de 12 semanas. Una puntuación ≥ 4 tras 8-12 semanas de dosis plenas exige cambio de estrategia terapéutica.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · DGRP

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Establecimiento de Línea de Base: Registrar DGRP-Gravedad antes de iniciar psicoterapia o farmacoterapia (basal: DGRP-Mejoría no aplica).

Paso 2: Monitorización a las 4, 8 y 12 semanas:

- **Si DGRP-Mejoría = 1 ó 2 (Respondedor):** Consolidar el tratamiento actual. En farmacoterapia, mantener tratamiento de mantenimiento mínimo 12 meses.
- **Si DGRP-Mejoría = 3 (Respuesta Parcial):** Optimizar dosis farmacológica (ej. sertralina hasta 200 mg/d o venlafaxina hasta 225-300 mg/d) y agregar terapia de exposición prolongada o EMDR.
- **Si DGRP-Mejoría $\geq$ 4 (No Respondedor o Empeorado):** Realizar diagnóstico diferencial (descartar consumo encubierto de alcohol, litigios judiciales abiertos, violencia doméstica activa) y rotar de fármaco o derivar a unidad de trauma complejo.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Mujer de 36 años, agente de policía, evaluada tras haber sobrevivido a un tiroteo en acto de servicio 7 meses antes. Presenta pesadillas vívidas recurrentes, taquicardia refleja ante ruidos secos, incapacidad para portar el uniforme y distanciamiento afectivo de su familia.

Evaluación Inicial Basal: DGRP-Gravedad = 6 ("Gravemente enferma"). Incapacidad laboral transitoria y aislamiento domiciliario total.

Curso y Seguimiento: Se instauró tratamiento combinado con sertralina (titulada hasta 150 mg/día) y terapia de Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares (EMDR).

- **Evaluación a las 4 semanas:** DGRP-Gravedad = 5 ("Marcadamente enferma"), DGRP-Mejoría = 3 ("Minimamente mejorada"). Ligera mejoría en conciliación del sueño pero persistencia de evitación fóbica.
- **Evaluación a las 12 semanas:** DGRP-Gravedad = 2 ("Dudosamente enferma"), DGRP-Mejoría = 1 ("Muy mejorada"). Remisión completa de las intrusiones y pesadillas diurnas, reintegrándose a tareas administrativas sin crisis autonómicas.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA

- Una calificación de DGRP-Mejoría = 6 o 7 (Empeoramiento) obliga a evaluar descompensación suicida aguda o reexposición traumática no declarada.
- No confundir embotamiento disociativo con respuesta terapéutica: el paciente que "no siente nada" puede aparentar calma pero sigue grave.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **Depresión Mayor Postraumática:** Puede enmascarar la mejoría del TEPT; evaluar síntomas nucleares afectivos independientes.
- **Simulación o Ganancia Secundaria:** Especialmente relevante en peritajes forenses y pensiones por incapacidad.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Davidson, J. R. T., Weisler, R. H., Malik, M., & Tupler, L. A. (1998). Fluvoxamine in civilians with posttraumatic stress disorder. *Journal of Clinical Psychopharmacology*, 18(1), 93–95.
- Guy, W. (1976). *ECDEU assessment manual for psychopharmacology* (DHEW Publication No. ADM 76-338). National Institute of Mental Health.
- Davidson, J. R., Rothbaum, B. O., van der Kolk, B. A., Sikes, C. R., & Farfel, G. M. (2001). Multicenter, double-blind comparison of sertraline and placebo in the treatment of posttraumatic stress disorder. *Archives of General Psychiatry*, 58(5), 485–492.
- Bobes, J., García-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3.ª ed.). Ars Médica.